

中医药治疗在慢性心力衰竭心脏康复中的应用研究进展

王 猛

(泰安市中医医院心血管病二科, 山东 泰安, 271000)

摘 要:慢性心力衰竭在临床中比较多发, 发病率高, 患者容易反复住院率, 死亡风险高。通过西医学治疗虽然能在一定程度上控制患者的病情, 但易产生耐药性以及出现不良反应, 不宜长期用药。中医药通过多靶点能够取得较好的疗效且安全性高。在该病患者心脏康复中通过中医辨证施治能够充分发挥中医药优势。本研究从慢性心力衰竭的中医病因病机、中医药治疗的作用机制、辨证分型、中医内治情况四个方面展开综述, 旨在促进该病患者心脏康复效果提升。

关键词:慢性心力衰竭; 心脏康复; 中医药; 汤剂

中图分类号: R256 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-8011(2025)-15-0083-03

慢性心力衰竭(Chronic Heart Failure, CHF)是一种复杂的临床综合征, 在中老年人、高血压及冠心病患者中较为高发, 具有发展缓慢、进展缓慢的特点^[1]。该病是心血管疾病的终末期表现, 也是主要死因。临床西医学治疗通过利尿、强心、扩张血管等措施, 能够促进患者衰竭心脏的生物学术性质改变。但单纯的西医治疗无法根治该病, 患者的生活质量也不能得到完全改善^[2]。应用西药治疗可在短期内控制患者病情, 阻止疾病持续进展, 但长期用药会导致严重不良反应, 降低患者依从性。心脏康复是指通过一系列的康复措施及方法促进患者心脏功能恢复、生活质量提高的方法, 而药物属于心脏康复五大处方中的重要内容^[3]。中医内治在疾病的治疗、康复中应用较为广泛, 且结合西医治疗更有助于康复效果的提高。本研究对中医内治在慢性心力衰竭心脏康复中的应用情况展开综述。

1 慢性心力衰竭的中医病因病机

慢性心力衰竭在中医中被归类于“心悸”“胸痹”“喘证”“水肿”“痰饮”等范畴。其病因病机复杂, 主要由情志失调、饮食不节、先天禀赋不足、外邪入侵等因素引起。情志失调会导致肝气郁结、气机失调, 进而影响气血运行, 导致气滞血瘀, 影响心脏功能; 饮食不节则使脾胃运化失常, 痰湿内生、痰湿阻滞中焦, 影响气血运行, 进一步导致心脉瘀阻并加重心脏负担; 先天禀赋不足, 尤其是肾气不足, 会导致肾精亏虚且无法滋养心脉, 在影响心阳的温煦和心阴的滋养的同时还易导致心功能失调; 外邪入侵, 如风寒、湿热等邪气, 可直接侵袭肺卫, 导致肺失宣降, 水液代谢失调, 痰饮内生, 痰饮阻滞心脉, 进而影响心脏的正常功能^[4]。

该病病机以本虚为主, 标实为辅。本虚主要表现为心阴不足和气虚阳微。心阴亏虚无法滋养心脉, 导致心悸、失眠、

烦躁等症状; 气虚阳微则导致心脏的泵血功能减弱, 具体表现为乏力、气短、畏寒等症状。标实主要表现为水饮内停、痰浊、血脉瘀阻。脾虚运化失常导致水饮内停, 影响气血运行; 饮食不节易导致痰湿内生, 痰浊阻滞心脉, 进一步导致心悸、胸闷等症状; 情志失调、气虚阳微等因素则会导致气滞血瘀, 瘀血阻滞心脉, 主要表现为胸痛、唇甲青紫等症状^[5]。

慢性心力衰竭的主要病位在心脏, 但病变过程同样会波及肝、脾、肾等脏腑。肝主疏泄, 情志失调易导致肝气郁结, 气滞血瘀; 脾主运化, 饮食不节导致脾虚, 运化失常, 痰湿内生, 影响气血运行; 肾为先天之本, 肾气不足会影响心阳的温煦和心阴的滋养, 导致心功能失调^[6]。

2 中医药治疗的作用机制

2.1 抗纤维化

心脏成纤维细胞活化会引起细胞外基质蛋白过度沉积, 促使慢性心力衰竭发生发展。基质金属蛋白酶(MMP-2)、MMP-9与细胞外基质重塑有关; 转化生长因子- β_1 (TGF- β_1)则参与了纤维化进程。中医药具有较好的抗纤维化作用, 如真武汤具有温阳利水作用, 其出自《金匮要略》, 可利尿、强心^[7]; 同时还能够促使慢性心力衰竭患者心肌纤维化程度减轻, 对TGF- β_1 的表达进行抑制。另外参竹心康汤、芪丹利心丸等中医药均可发挥抗心肌纤维化作用, 有助于该病患者心功能改善。

2.2 抗炎

炎症反应系统激活会损伤患者的心肌细胞, 引起心室重构, 降低患者的心功能。与心力衰竭相关的炎症细胞因子包括白细胞介素-1 β (IL- β)、IL-6、IL-10等以及C反应蛋白(CRP)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α)等。上述因子会导致患者出现心肌肥大、纤维化情况, 促使细胞凋亡, 进而引起心力衰竭。应用振源稳心汤对慢性心力衰竭患者进行治疗, 可降低血清IL-6、超敏C反应蛋白(hs-CRP)、TNF- α 水平, 提高患者的心功能^[8]。此外, 加味丹参饮、益气通脉饮等复方也有助于延缓心室重塑。

基金项目: 益阳利水法在急性左心衰治疗中的临床应用研究(2023NS198)。

作者简介: 王猛(1986—), 男, 汉族, 籍贯: 山东省泰安市, 硕士研究生, 主治医师, 研究方向: 心血管病。

2.3 调节心肌细胞自噬水平

细胞凋亡会导致心功能障碍,影响心脏结构,导致心力衰竭的发生和发展。心脏中心肌细胞自噬水平过高会加快心功能恶化速度,而适度自噬可延缓疾病进程。中药汤剂通过调节自噬水平,可有效调节患者心肌细胞,阻止心肌细胞凋亡。如黄芪保心汤通过调节心肌 Bcl-2 等表达水平能够抑制心室重构和内质网应激凋亡进行抑制,起到保护心肌细胞的作用。

2.4 改善线粒体能量代谢

心肌线粒体能量代谢能够使心肌细胞活动得以维持,当出现心肌线粒体能量代谢障碍时,会影响患者的心功能,导致心力衰竭。附子、黄芪、党参等中药能够调节心肌能量代谢蛋白,阻止心肌细胞凋亡,解决线粒体功能障碍的问题,有助于减轻心力衰竭症状和提升心功能。复方参附汤、参麦注射液等能够纠正能量代谢紊乱情况,对腺苷酸活化蛋白激酶 (AMPK) 等蛋白进行调控,从而能够改善线粒体能量的代谢。

2.5 抗氧化

活性氧增多会引起氧化应激,导致心脏重塑、心力衰竭。乌头、人参等中药中的成分具有抗氧化作用,如人参皂苷 Rb1 能够介导 AMPK 通路,促使自噬相关蛋白表达水平下降,有助于提高心肌细胞耐缺氧能力,抑制过度自噬;乌头提取物、苦参素、麦冬可减轻使氧化应激,对心脏起到保护作用。

2.6 调节神经-体液机制

维持心排量神经体液过度活跃会引起心肌收缩功能障碍,神经方面主要为交感神经系统 (SNS),主要表现为血浆去甲肾上腺素 (NE) 增多;体液方面主要为肾素-血管紧张素-醛固酮系统 (RAAS),可观察到激素分泌明显增加。SNS、RAAS 系统均会引起心肌细胞肥厚、纤维化,导致心肌细胞凋亡、心室重构,最终形成慢性心力衰竭^[9]。闫稳平等^[10]研究显示,研究组在常规治疗 (对照组) 的基础上联合温阳通脉汤治疗,结果显示,研究组的临床疗效总有效率 (89.9%)、治疗后的 6MWB 评分以及超氧化物歧化酶 (SOD) 和总抗氧化能力 (TAC) 水平均高于对照组,而丙二醛 (MDA)、过氧化脂质 (LPO) 水平均低于对照组,这表明温阳通脉汤疗效显著,可促进患者活动耐力提高并减轻氧化应激反应。此外,加味四逆汤、益气振心汤等汤剂能够调节 SNS 系统与 RAAS 系统,有助于心脏康复。

3 中医内治辨证施治

慢性心力衰竭的辨证分型比较复杂,主要侧重五脏、标本虚实、阴阳、经络,依据慢性心力衰竭病因病机分型,可分为气虚血瘀型、心肾阳虚型、气阴两虚型、心血瘀阻型以及阳虚血瘀水停型。

3.1 气虚血瘀型

气虚血瘀是指由气虚引起的血液瘀滞现象,会导致患者出现面色淡白或晦滞、精神疲劳、体倦乏力、少气懒言、胸胁部疼痛等症候。针对该证型,临床遵循益气活血的原则,一般应用补阳还五汤、四君子汤、血府逐瘀汤、益气活血方等汤剂,以及中成药如补中益气丸、复方丹参滴丸等进行调理。马

学竹等^[11]在气虚血瘀型慢性心力衰竭患者治疗中应用保元汤促进了临床有效率、左室射血分数的提高,促使血清 NT-proBNP 和 BNP 水平下降,有利于提升生存质量。吕运歌^[12]研究报告,西药组应用左西孟旦治疗,联合组加用芪参益气活血方治疗,结果显示,联合组的总有效率 (91.67%) 高于对照组,中医证候积分、心功能分级及血清水平 N 末端脑利钠肽前体 (NT-proBNP)、促生长因子 (IGF-1)、肌钙蛋白 (cTnT) 水平均优于对照组。上述研究中所用中医内治方法能够较好地减轻中医证候及心力衰竭症状,并可提高临床疗效。同时针对气虚血瘀水停型慢性心力衰竭,益气活血利水方能够更好地促进患者 6 min 步行距离以及中医证候评分改善,增强患者心肺功能和运动耐力,提升患者生命质量^[13]。陈爱党等^[14]研究显示,复方丹参滴丸联合曲美他嗪治疗老年慢性心力衰竭可显著提高临床总有效率 (96.00% vs 82.00%),降低血清细胞因子 CRP、MMP-9、BNP 水平,改善心功能指标左心室收缩末期内径 (LVESD)、左心室舒张末期内径 (LVEDD)、左心室射血分数 (LVEF),且不增加不良反应发生率。复方丹参滴丸通过活血化瘀、益气养阴,改善微循环,在减轻心肌缺血的同时降低血液黏稠度,从而缓解气虚血瘀型心力衰竭患者的症状。

3.2 心肾阳虚型

心肾阳虚型主要是由年老体衰、久病失养所致,以心悸、水肿、畏寒等为主要症状。临床治疗应注重温补肾阳、提振心阳,可应用瓜蒌薤白桂枝汤、参附汤合右归饮加减、参附强心方加减等中药汤剂治疗。此外,还可结合参附注射液,中成药如金匱肾气丸、右归丸等进行调理,同时配合中药药膳,如生姜羊肉汤,以温阳利水、助阳益气,进一步增强疗效。高阳^[15]的研究中,根据是否应用真武汤加减方分为对照组 (未使用) 和试验组 (使用) 各 34 例,经过 3 个月治疗后,试验组的 LVESD、LVEDD、舒张末期左心室后壁厚度 (LVPW)、LVEF、每搏输出量 (SV)、心输出量 (CO) 均优于对照组,总有效率 (94.12%) 更高。真武汤能够温阳利水、扶正祛邪、健脾燥湿、安神定志,能够促进患者身体素质提升。徐慧等^[16]研究结果显示,参附注射液联合曲美他嗪治疗心肾阳虚老年慢性心力衰竭患者,总有效率为 95.35%,显著高于单用曲美他嗪的 79.07%,能显著改善心功能指标 (SV、LVEF、CO 提高, LVEDD 降低) 及运动耐力 (6MWT 增加),并降低不良反应发生率 (9.30%),与单用曲美他嗪相当。参附注射液以红参、附子为主,红参补气固脱,附子温阳救逆,二者协同,温补心肾阳气,回阳救逆,从而改善心肾阳虚型心力衰竭患者的心功能与症状。闫晓丽等^[17]则认为,对于心肾阳虚证慢性心力衰竭患者,在西医规范化药物治疗的基础上联合参附强心方取得的效果优于单纯西药治疗。参附强心方能够起到益气助阳、利水消肿、强心、抗炎、抗心律失常等作用,不仅能够改善临床症状,而且有利于改善血液循环、心肌缺血缺氧情况,促进心功能恢复。

3.3 气阴两虚型

气阴两虚是指同时出现气虚和阴虚状态的情况,气虚与机体生理功能低下有关,会出现自汗、乏力、气短等症状;阴虚则

与体内阴液不足等有关,以口干、眼干、盗汗等症状为主。针对气阴两虚型患者,治宜益气养阴,推荐服用人参生脉饮、炙甘草汤、参芪地黄汤等方剂,也可选用中成药如生脉胶囊、生脉注射液等进行调理,并结合药膳如百合银耳羹,以滋阴润燥、益气养阴^[17-18]。高中宇^[19]的研究中对气阴两虚型慢性心力衰竭患者辅以保元汤合桂枝甘草汤治疗,结果显示疗效显著,促进了患者心功能及血清炎症因子水平的改善。生脉散加味治疗能够促使此类患者的 24 h 尿量增加,可减轻利尿剂抵抗情况,能够有效控制病情,促进患者心功能改善。寿旦等^[20]研究发现,参麦注射液治疗气阴两虚型老年慢性心力衰竭患者,总有效率为 84.00%,显著高于西药组的 76.00%。治疗后,患者 NT-proBNP 水平从 (1125.00 ± 81.78) pg/mL 降至 (785.66 ± 55.68) pg/mL。参麦注射液中红参、麦冬和五味子可益气养阴、补心安神,改善气阴两虚型慢性心力衰竭患者的症状并提升心脏功能。

3.4 心血瘀阻型

心血瘀阻型是由多种原因所致的血液运行受阻情况,会导致患者出现心胸憋闷、疼痛、心悸等症状,治宜活血通络、养心安神,可在医师指导下应用桃红四物汤加味、养心汤等方剂以及中成药如复方丹参滴丸、血府逐瘀丸等进行调理治疗。针对心血瘀阻型冠心病慢性心力衰竭,益气活血、通阻养心方联合常规西药治疗能够发挥益气活血、散瘀通络、补益心脾等作用,同时能够扩张冠状动脉,促进冠状动脉血流量增加,并且能够对心肌肥大、细胞凋亡进行抑制,并可对心肌重塑进行抑制,较好地改善心功能^[21]。率中泰等^[22]研究发现,复方丹参滴丸联合阿托伐他汀钙治疗老年慢性心力衰竭总有效率为 95.65%,高于单用阿托伐他汀钙的 80.43%,且治疗后心功能指标和 6 min 步行距离显著改善,血清细胞因子和血管活性物质水平也显著降低。复方丹参滴丸通过活血化瘀、增加冠状动脉血流量、抑制血小板聚集、减少自由基生成,改善心功能的同时并减轻炎症反应,促进心肌细胞修复。

3.5 阳虚血瘀水停型

阳虚血瘀水停主要是由体内阳气不足所致,临床治疗应注重益气温阳、化瘀利水。徐海丰等^[23]、金蕾等^[24]分别应用利水强心汤、温阳益心汤对此证型慢性心力衰竭患者进行治疗,均取得了较好的疗效。何军等^[25]研究发现,心宝丸联合常规治疗老年慢性心力衰竭(阳虚血瘀证)患者总有效率为 96.30%,显著高于单用常规治疗的 83.02%。心宝丸通过温补心肾、益气助阳、活血通脉,可减轻心肌纤维化。

4 小结

本研究通过中医药作用机制、辨证分型论治等方面进行综合分析,发现中医内治在慢性心力衰竭心脏康复中具有重要价值,具有抗炎、抗纤维化、减轻应激反应、改善心功能、抑制心脏重构等多种作用。

参考文献

[1] 陈小倩,黄武松,李茜羽,等.心脾同治法干预老年慢性心力衰竭临床观察[J].山西中医,2023,39(3):10-12.

- [2] 吴美娟,倪代梅,张浩,等.自拟平喘散穴位贴敷治疗阳虚水泛型慢性心力衰竭的临床疗效观察[J].中医药临床杂志,2023,35(12):2424-2428.
- [3] 邹晓琪,周狄,陈伶利,等.升陷汤联合隔物灸治疗慢性心力衰竭临床观察[J].山西中医,2023,39(1):12-14.
- [4] 陈宵宵,吴桂仙.中医健脾和胃法治疗冠心病慢性心力衰竭临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2023,21(15):78-80.
- [5] 苗倩,林乐堃,李卓伟,等.耳穴压豆联合 I 期心脏康复对心衰患者运动耐力、NT-proBNP 及超敏 C 反应蛋白影响的研究[J].系统医学,2023,8(21):24-27.
- [6] 李志平,胡海莉.心衰协定方联合心脏康复对慢性心力衰竭患者 6MWT、LVEF 及血浆 NT-proBNP 水平的影响[J].中国处方药,2022,20(7):69-71.
- [7] 张辉.真武汤合瓜蒌薤白半夏汤加减治疗阳虚水泛型慢性心力衰竭临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2023,21(16):45-47.
- [8] 于泳.振源稳心汤治疗慢性心力衰竭临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2022,20(24):97-98,107.
- [9] 龚帆影,杜玉颖,李佳,等.抗心衰方对慢性心力衰竭患者心功能及氧化应激功能的影响[J].南京中医药大学学报,2023,39(2):118-123.
- [10] 闫稳平,张志强,王君,等.温阳通脉汤治疗慢性心力衰竭临床疗效及对患者活动耐力、氧化应激指标、cTnI 与 BNP 水平的影响[J].长春中医药大学学报,2022,38(9):1007-1010.
- [11] 马学竹,王妙然,李秋艳.保元汤治疗气虚血瘀型慢性心力衰竭临床观察[J].光明中医,2022,37(16):2868-2874.
- [12] 吕运歌.芪参益气活血方治疗气虚血瘀型慢性心力衰竭临床观察[J].光明中医,2021,36(5):774-776.
- [13] 孙嘉豪,李衍达,邢雁伟.益气活血利水方治疗气虚血瘀水停型慢性心力衰竭的临床研究[J].世界中医药,2023,18(20):2941-2944.
- [14] 陈爱党,高慧.复方丹参滴丸对老年慢性心力衰竭患者血清细胞因子水平及心功能指标的影响[J].实用中西医结合临床,2021,21(17):11-12.
- [15] 高阳.真武汤治疗心肾阳虚型慢性心力衰竭临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2022,20(4):90-92.
- [16] 徐慧,吴少俊.参附注射液联合曲美他嗪对慢性心衰患者心功能及运动耐量的影响[J].中国卫生工程学,2024,23(6):811-813.
- [17] 闫晓丽,常立萍,石锐,等.参附强心方加减治疗心肾阳虚证慢性心力衰竭的临床效果[J].中国老年学杂志,2023,43(15):3588-3591.
- [18] 张林娜,王伟,王晓蒙.益气养阴方治疗气阴两虚型慢性心力衰竭临床观察[J].河南中医,2024,44(5):739-743.
- [19] 高中宇.保元汤合桂枝甘草汤治疗气阴两虚型慢性心力衰竭临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2023,21(2):113-115.
- [20] 寿旦,楼益平.参麦注射液治疗气阴两虚型慢性心力衰竭的临床观察[J].浙江中医杂志,2022,57(5):340.
- [21] 闫安平.生脉散加味对气阴两虚型慢性心力衰竭患者利尿剂抵抗的改善作用[J].现代中西医结合杂志,2021,30(23):2576-2580.
- [22] 率中泰,刘小娟.复方丹参滴丸联合阿托伐他汀钙治疗慢性心力衰竭临床观察[J].中国卫生标准管理,2024,15(3):141-145.
- [23] 徐海丰,徐博文,孙梦婷.利水强心汤治疗慢性心力衰竭阳虚血瘀水停型 68 例[J].光明中医,2023,38(18):3589-3592.
- [24] 金蕾,潘东辉.温阳益心汤对慢性心力衰竭(阳气虚衰、血瘀水停型)心功能和炎症因子的影响[J].光明中医,2021,36(5):760-763.
- [25] 何军,张宏.心宝丸对阳虚血瘀证老年慢性心力衰竭患者的临床疗效[J].中成药,2024,46(6):2121-2124.